



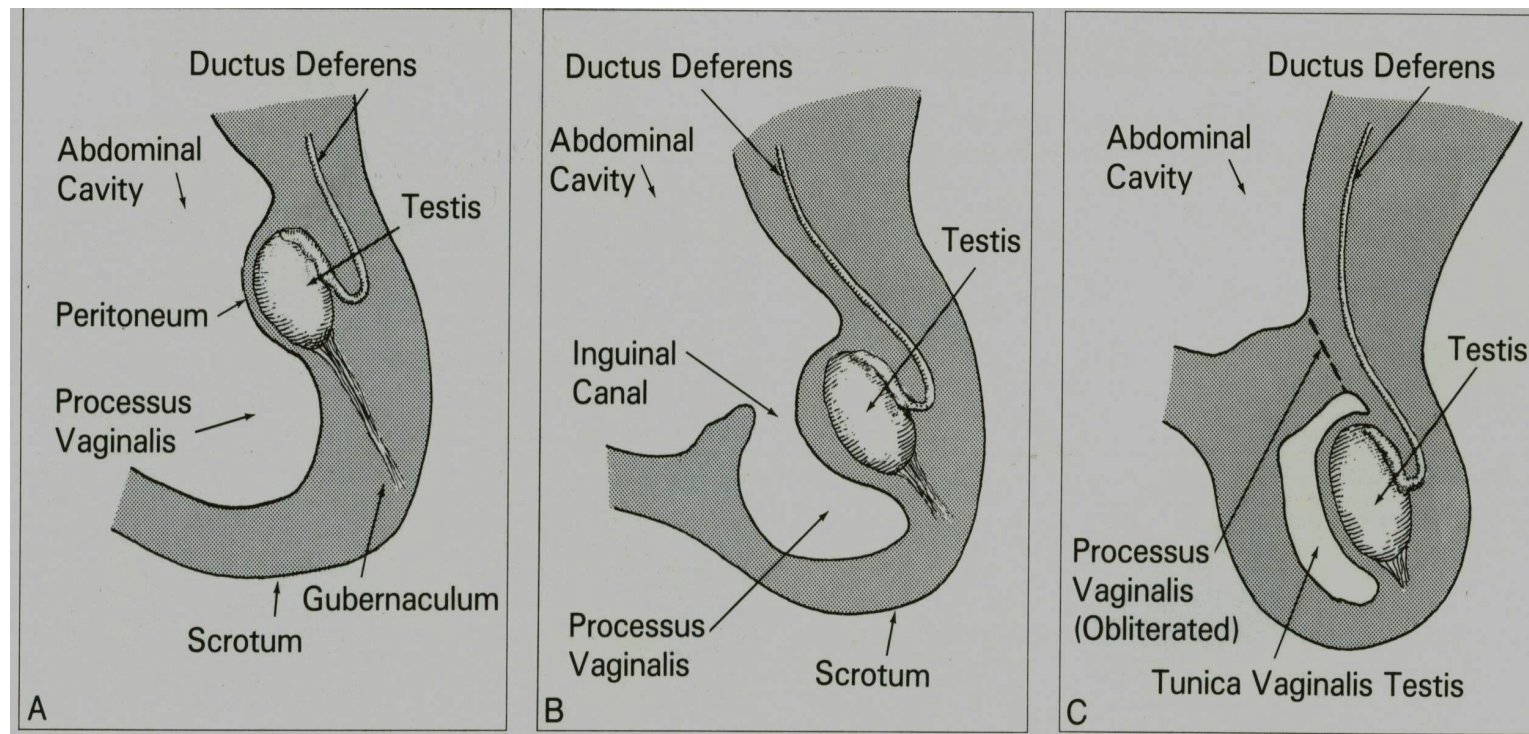
HERNIE INGUINALE

Embryologie:

- à la fin du 3ème mois intra-utérin, le péritoine pariétal s'invagine avant les vaisseaux épigastriques;
- se forme le canal péritonéo-vaginal qui se termine dans le scrotum par une tunique vaginale;
- chez le sexe féminin le processus vaginal descend selon la direction du ligament rond jusqu'à la région labiale = *canal Nück*;
- chez le sexe masculin le testicule et les éléments du cordon spermatique, descendent vers le scrotum et adhèrent au canal péritonéo-vaginal;
- l'hernie inguinale est une des affections chirurgicales pédiatriques les plus communes.



HERNIE INGUINALE





HERNIE INGUINALE

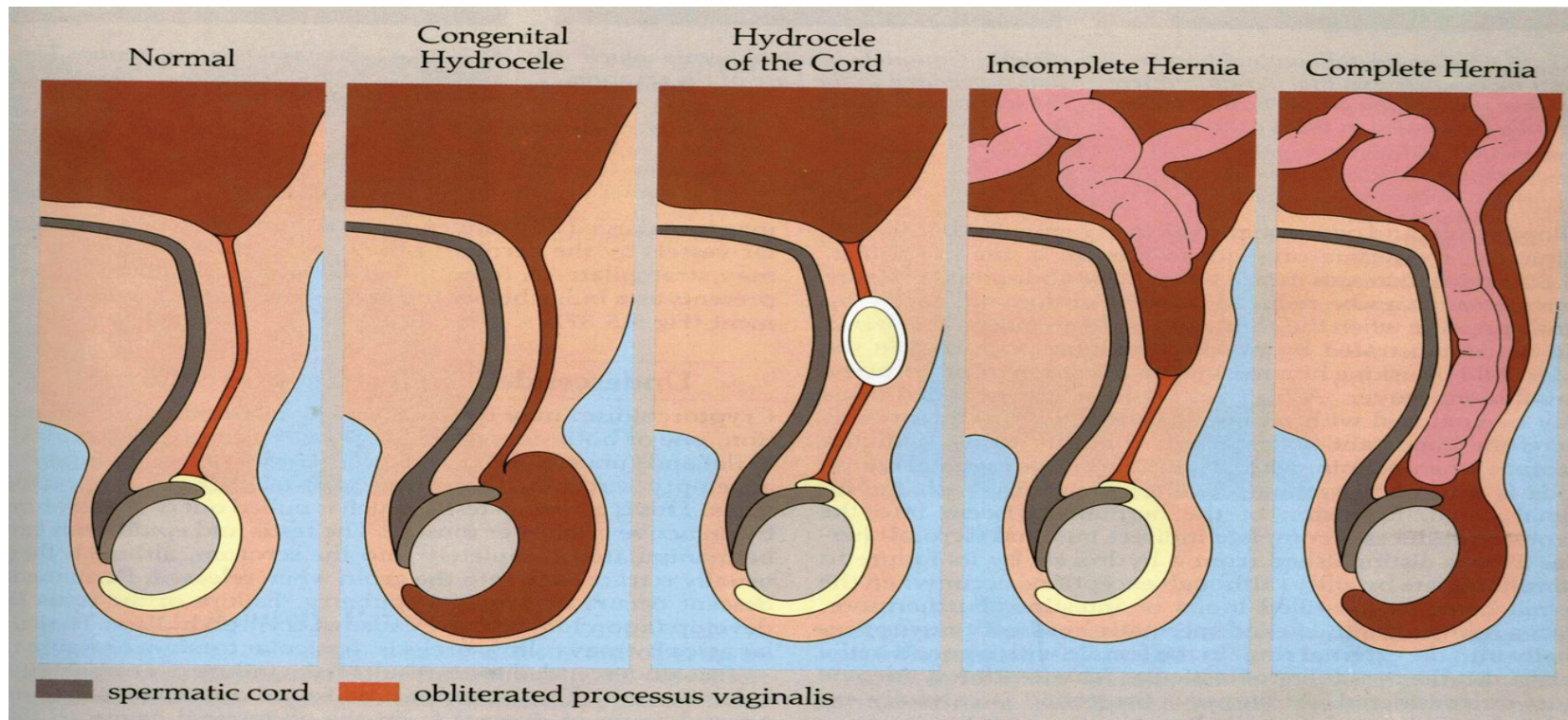
Anatomie pathologique:

- l'involution du canal péritonéo-vaginal se produit idéalement le dernier mois de grossesse;
- dans 80- 90% des cas cette involution se fait plus lentement, ainsi à 1 an, dans la moitié des cas le canal est encore ouvert ou incomplètement fermé;
- le processus de sclérose et d'atrophie début au niveau des anneaux de Ramonède;
- l'absence d'oblitération partielle ou totale du canal permet l'engagement de l'intestin, le transformant en sac herniaire



HERNIE INGUINALE

Hernie inguinale et hydrocèle -Genèse



SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



HERNIE INGUINALE

Hernie inguinale chez le sexe masculin

Nouveau-né et nourrisson:

- peut apparaître avec les premiers pleurs, surtout chez les prématurés ou à cause de l'effort de toux ou de miction difficile (sténose du méat, phymose serrée), états de constipation;
- par augmentation de la pression abdominale le canal s'élargit et permet l'engagement et la progression d'une anse abdominale;
- l'hernie devient visible sous la forme d'une **tumeur** de grandeur variable, située au dessus du pubis en regard de l'orifice externe du canal inguinal



HERNIE INGUINALE

· Hernie inguinale chez le sexe masculin

- dans la majorité des cas se réduit spontanément, si elle est volumineuse se maintient pendant aussi au repos et descend dans le scrotum;
- si elle réapparaît après réduction au repos = ***hernie incoercible***;
- à l'occasion de la réduction on apprécie la taille de l'orifice inguinal externe par insertion du petit doigt à partir du scrotum;
- si l'hernie apparaît de façon intermittente à l'effort, elle peut se mettre en évidence pendant les pleurs ou par application d'une pression manuelle sur l'abdomen, ou par positionnement du nourrisson en orthostatisme



HERNIE INGUINALE

· Hernie inguinale chez le sexe masculin

- *Chez le grand enfant*

- moins de symptômes,
- étant de petite dimension,
- non douloureuse,
- visible seulement à l'effort et à l'effort de toux (excepté les cas d'hernie négligée, grande, incoercible);
- à l'examen physique on met en évidence **l'élargissement de l'orifice externe et du canal inguinal** du côté de la lésion;
- dans tous les cas il faut vérifier la présence des testicules dans le scrotum



HERNIE INGUINALE



Hernie inguinale



Hernie inguino-scrotale



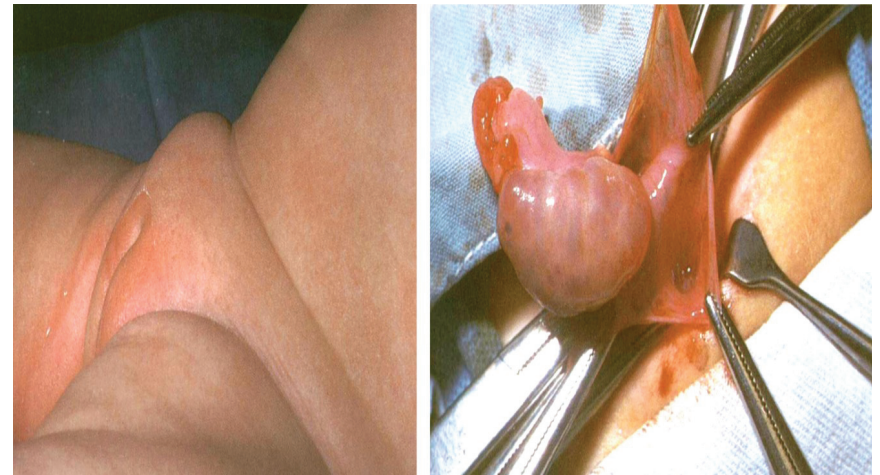
SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



HERNIE INGUINALE

Hernie inguinale chez le sexe féminin

- plus rare que chez le sexe masculin (rapport 10/1),
- rarement visible chez les nourrissons,
- d'habitude devient visible après quelques années,
- souvent bilatérale;
- dans le canal péritonéovaginal non oblitéré (Nüch) pénètre , l'intestin ou l'ovaire et la trompe;
- les dimensions sont plus petites et la strangulation est très rare et intéresse l'ovaire,(absence de vomissements et de transit arrêté;)
- une réduction difficile signifie l'engagement d'un ovaire ou d'un kyste du canal de Nüch similaire à l'hydrocèle funiculaire chez les garçons.



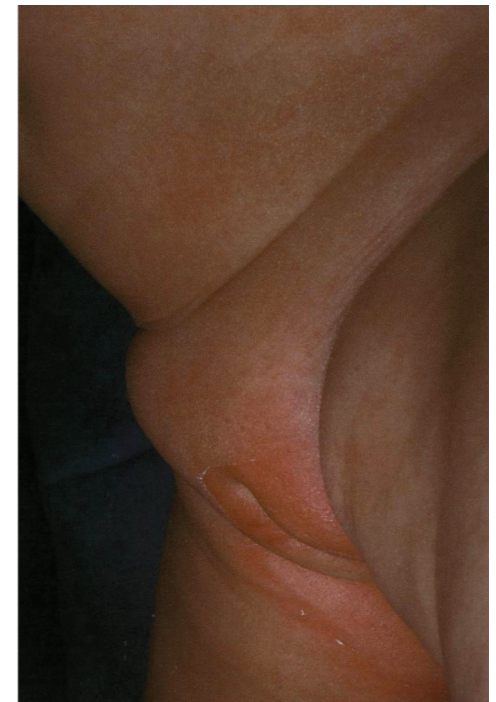
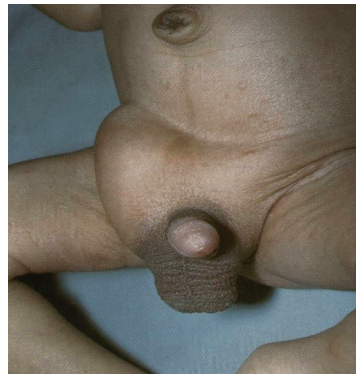
Hernie inguino-labiale droite, hernie de l'ovaire



HERNIE INGUINALE

Diagnostic:

- facile par examen clinique, si l'hernie est visible on tente la réduction par pression manuelle lente et on vérifie la taille de l'orifice inguinal externe par appréciation face à l'orifice controlatéral;
- la palpation pendant l'effort de toux aide le diagnostic





HERNIE INGUINALE

Diagnostic différentiel:

- avec l'**hydrocèle vaginal et funiculaire**, fréquents chez les nourrissons mais qui disparaissent dans les 6 premiers mois dans la plupart des cas;
- l'**hydrocèle vaginal**, est souvent bilatéral chez le nourrisson, élastique, et le testicule se trouve au pôle inférieur de la tumeur; le matin le volume est réduit et l'effort mène à l'accumulation de liquide qui le fait doubler de volume le soir
- l'**hernie strangulée** doit être différenciée du **kyste du cordon** qui n'est pas réductible, douloureux, et qui ne vient pas avec les signes d'occlusion et d'agitation;
- **cryptorchidie** - mène à des confusions si on ne vérifie pas la présence des testicules dans le scrotum;
- chez les filles avec **kyste du cordon Nück** irréductible, élastique, mobile, non douloureux.



HERNIE INGUINALE

Évolution, Complications:

- l'hernie peut disparaître durant la première année, mais d'habitude elle progresse selon d'autres dimensions;
- **la complication la plus fréquente est la strangulation** et elle survient surtout chez les nourrissons dans les 3 premiers mois de vie, étant la principale cause d'occlusion intestinale à cet âge;
- la strangulation chez l'enfant est moins grave que chez l'adulte,
- chez les nourrissons surviennent des strangulations répétées qui disparaissent spontanément par bains chauds ou pendant le sommeil;
- quelques fois, par compression sur le canal spermatique peut se produire **l'ischémie et la nécrose de la gonade**



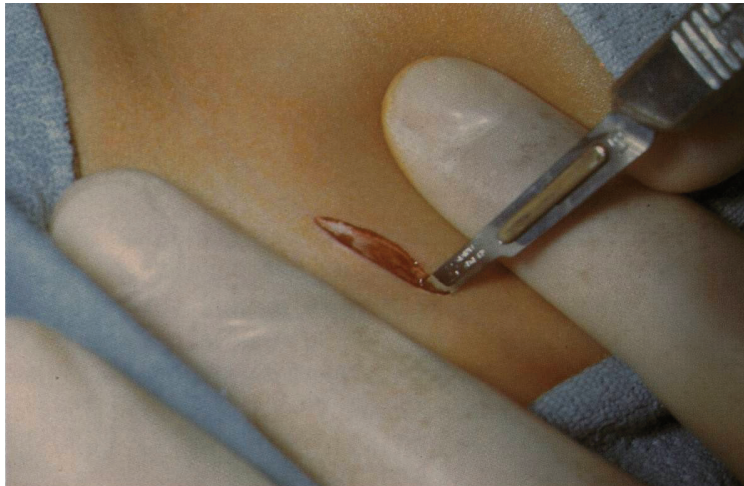
HERNIE INGUINALE

Traitement:

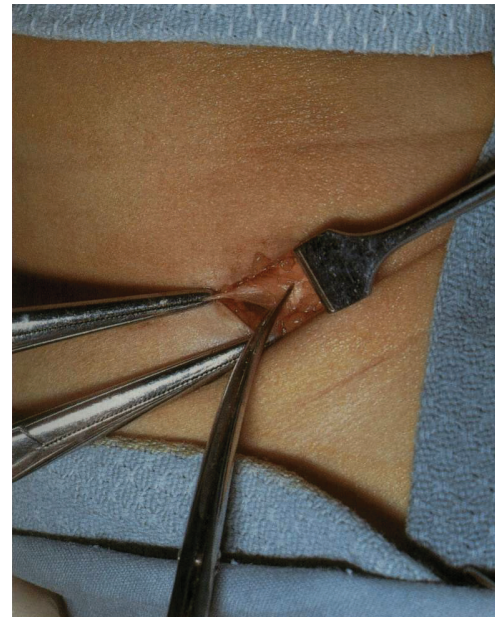
- **chirurgical**, en principe à tout âge mais préférable après 6 mois sans complications;
- vise **la ligature du canal péritonéo-vaginal à sa base**;
- ne nécessite pas de procédure de consolidation de la paroi;
- **chez les filles** -le sac herniaire se sectionne en bloc avec le ligament rond, mais le segment péritonéal s'ancre au tendon conjoint (procédé Barker) pour prévenir une déviation utérine.



HERNIE INGUINALE



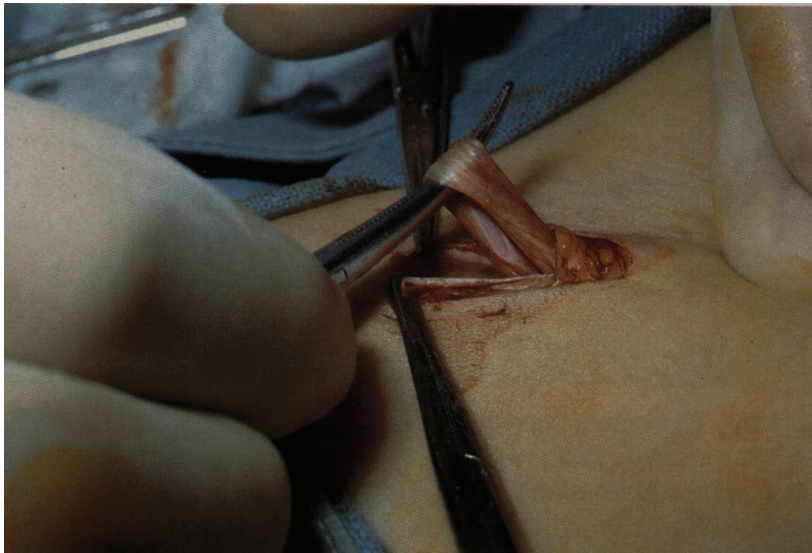
Incision tégumentaire transversale dans le pli abdominale inferieur centrée sur l'orifice superficiel du canal inguinal



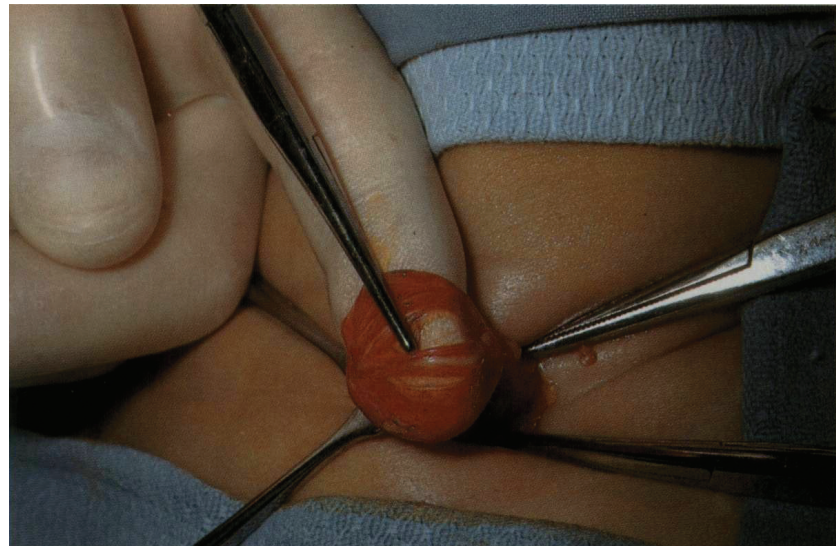
Ouverture du canal inguinal par section longitudinale de l'aponévrose oblique externe



HERNIE INGUINALE



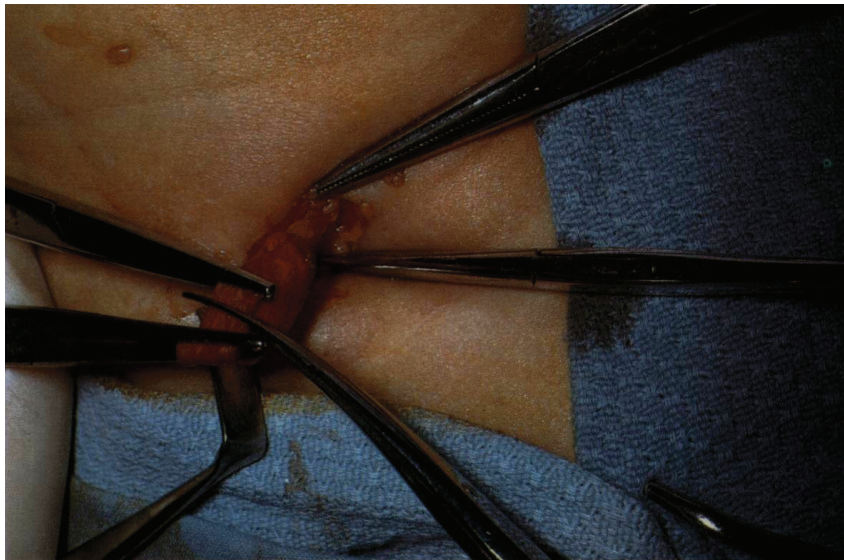
Mis en évidence du cordon spermatique avec sac herniaire



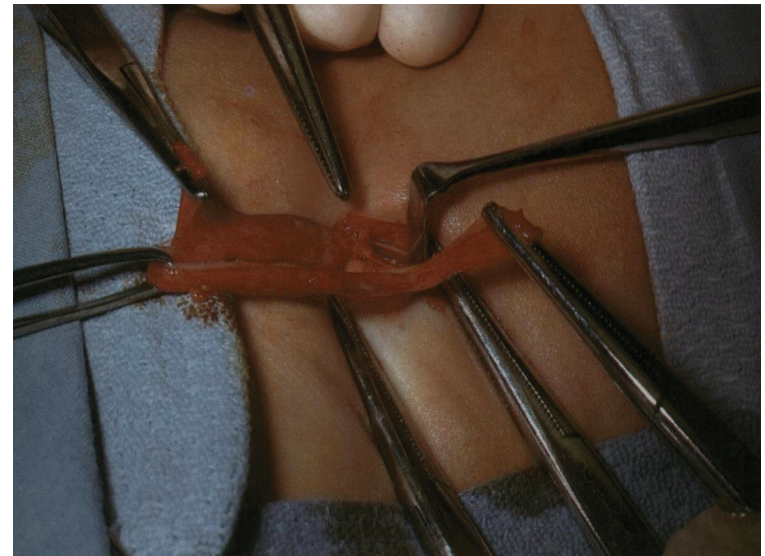
Dissection et isolation des éléments du cordon spermatique



HERNIE INGUINALE



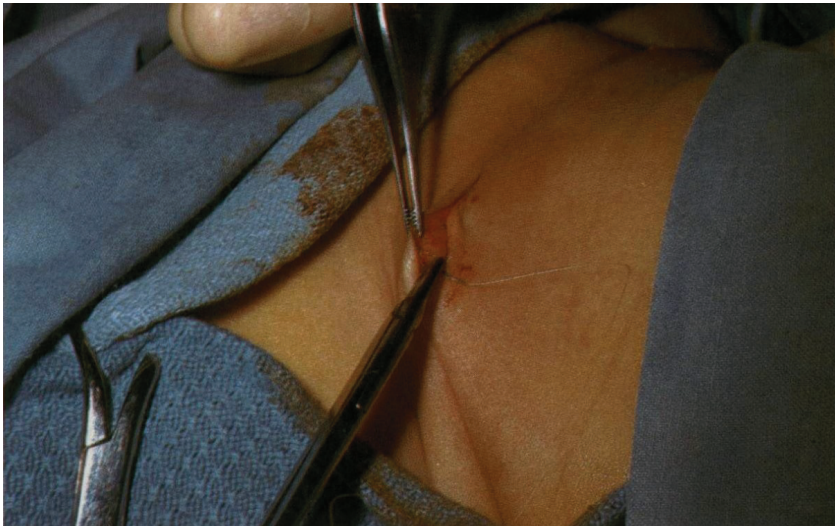
Section du sac herniaire



Fermeture du péritoine avec fil transfixiant au niveau du canal inguinal profond.



HERNIE INGUINALE



Fermeture du canal inguinal par suture aponévrose oblique externe et recalibrage de l'orifice superficielle.



Hernie inguinale - aspect postopératoire



HERNIE INGUINALE



Hernie inguino-labiale: ovaire et trompe de Fallope



Réintégration de l'ovaire dans la cavité abdominale



HERNIE INGUINALE

Hernie inguinale strangulée

- complication d'une hernie inguinale existante;
- chez le nourrisson peut être le premier signe de manifestation.

Symptômes:

- **douleur** - se manifeste par des pleurs inhabituels et agitation, après des périodes courtes d'accalmies, ils réapparaissent spontanément ou après mouvement;
- **vomissements** - mènent à la déshydratation;
- **arrêt du transit intestinal** - signe tardif, il ne faut pas attendre;
- dans les strangulations latérales incomplètes apparaissent les selles diarrhéiques et hémorragiques;
- **la tumeur inguinale** est le signe le plus important – forme ronde, consistance ferme, mobilité réduite, pole supérieur grossi qui se continue dans le canal inguinal, douloureuse si palpée;



HERNIE INGUINALE

Hernie inguinale strangulée

- dans les formes volumineuses, scrotales, le tégument est ;
- détendu,
- brillant,
- souvent violacée;
- quelques fois elle peut se réduire spontanément dans le sommeil, mais elle est plus souvent irréductible.

Diagnostic:

- facile à établir sur la base du tableau clinique;
- chez les nourrissons jusqu'à 3 mois, **l'hernie strangulée est la cause la plus fréquente d'occlusion intestinale.**



HERNIE INGUINALE

Diagnostic différentiel:

- **kyste du cordon ou hydrocèle funiculaire** - non douloureux à la palpation, mobilité latérale, ne se continue pas dans le canal inguinal, sans signes d'occlusion;
- **adénite inguinale aiguë** - signes locaux d'inflammation;
- **péritonite herniaire**: par l'hernie et la strangulation de l'appendice ou du diverticule Merckel;
- local, tumeurs plus dures avec signes d'inflammation;
 - vomissements,
 - fièvre,
 - leucocytose,
 - le transit intestinal n'est pas interrompu.
- **torsion du testicule cryptorchidie** - se constate l'absence du testicule dans le scrotum.



HERNIE INGUINALE

Évolution:

- moins graves que chez l'adulte;
- les strangulations répétées sont plus fréquentes chez les nourrissons par un anneau plus étroit et élastique ce qui détermine plus rarement la nécrose de l'anse;
- se réduisent spontanément pendant le sommeil ou le transport,
- la prolongation du temps de strangulation au dessus de 24 heures présente le risque de compromission de l'anse intestinale.

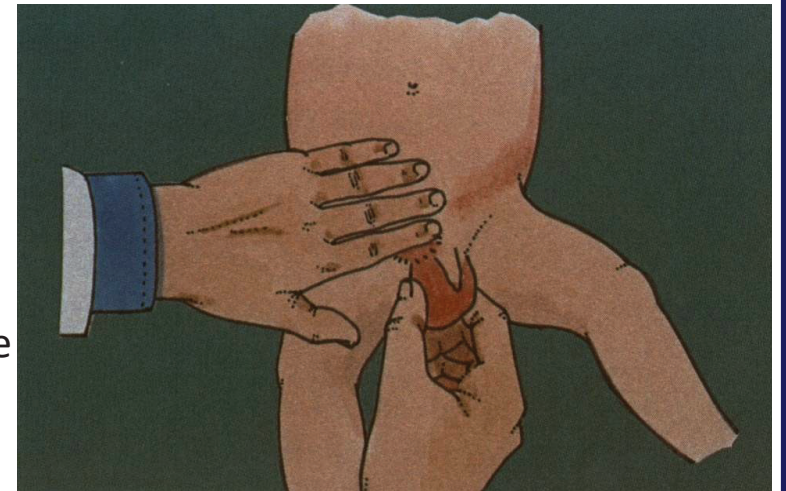




HERNIE INGUINALE

Traitement:

- chez les nourrissons et les petits enfants, on réalise la **réduction de l'hernie** par des bains chauds après administration de sédatifs;
- la **réduction de l'hernie par taxis** nécessite une surveillance et une intervention chirurgicale 2-3 jours après la résorption de l'oedème;
- **chirurgie d'urgence** :
 - taxis échoué;
 - strangulation >10 heures;
 - formes sévères avec possibles lésions viscérales et altération de l'état général.
- après réalisation de l'incision du sac, on ouvre distalement du collet, on protège l'anse avec une compresse et on sectionne le collet en inspectant l'anse
- d'habitude se recoloré en quelques minutes;



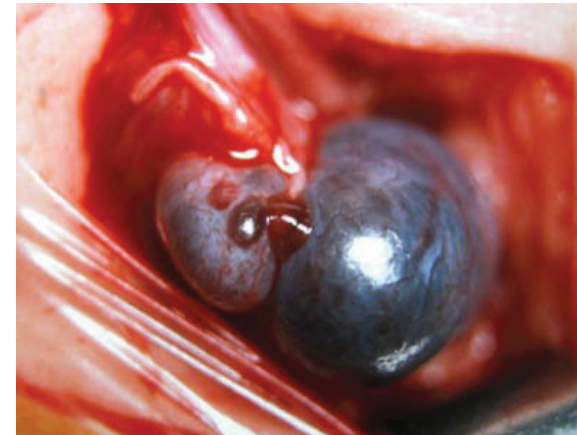
Réduction de l'hernie inguinale étranglée par taxis.



HERNIE INGUINALE

Traitement:

- en cas de nécrose est nécessaire;
- la suture avec fermeture en bourse,
- ou bien la résection de l'intestin,
- le diverticule Merckel ou l'appendice strangulé se résèque;
- chez les enfants de moins de 2 ans l'hernie strangulée opérée tard peut mener à l'infarctisation du testicule;
- chez les filles la strangulation est très rare et intéresse l'ovaire en général (incarcération) sans compromettre l'organe.





Hydrocèle

- Une formation kystique avec contenu de liquide clair, situé dans un reste de canal péritonéo-vaginal.

Embryologie:

- commune à l'hernie inguinale.

Anatomie pathologique

- il existe plusieurs formes d'hydrocèle, le plus fréquent étant l'**hydrocèle vaginal**, avec accumulation de liquide dans la vaginale testiculaire, le reste du canal étant fermé, ou ayant encore une communication avec le péritoine - **hydrocèle communiquant**;

- il existe des situations, quand il se forme entre les deux anneaux de Ramonede fermés, réalisant un **hydrocèle funiculaire ou kyste du cordon** (dans de rares cas existe aussi chez les femmes - **kyste du canal Nück**).



Hydrocèle

Tableau clinique:

- formation tumorale non douloureuse, ronde-ovale, lisse, avec distension du tégument scrotal;
- consistance élastique, liquidienne, et le testicule se trouve au pôle inférieur;
- est souvent bilatéral, fréquent chez les nouveau-nés, disparaît spontanément dans la majorité des cas jusqu'à l'âge de 6- 12 mois;
- dans le cas de l'hydrocèle communicant, les dimensions différent en fonction de l'effort physique, et il est plus grand le soir;
- en général la forme communiquant ne se guérit pas;
- les kyste du cordon se présente comme une formation petite, ovoïde, mobile, sans modifications de volume, non douloureuse et irréductible.



Hydrocèle

Diagnostic différentiel:

- avec **hernie inguinale** -réductible;
- **kyste du cordon** avec **hernie strangulée** - le kyste est non douloureux, à une grande mobilité, et le pôle supérieur se termine au niveau de l'orifice externe du canal inguinal alors que dans l'hernie strangulée il se continue avec le canal;
- les **tumeurs testiculaires** se différencient par le volume augmenté du gland.



Hydrocèle

Traitement:

- chirurgical, après l'âge de 1 an;
- l'abord est le même que pour l'hernie;
- est nécessaire l'interruption de la continuité entre le canal péritonéo-vaginal et la cavité péritonéale;
- le sac d'hydrocèle s'ouvre de façon longitudinale et se résèque partiellement ou se suture autour du cordon spermatique;
- l'hydrocèle funiculaire se sépare avec attention des éléments du cordon spermatique et se résèque.



Hydrocèle



Hydrocèle droit - aspect clinique et intra-opératoire